

MEMO STRATEGICO RISERVATO

Skylabs o Venere

Su cosa puntare dal 1° settembre 2026 — e come eseguirlo

Preparato per Luca Martino · Riservato e confidenziale

Basato sui deck “Skylabs AI Evolution” e “Venere”, sul Company Profile 2026 e sui dati 2025

Analisi & decisione · Struttura societaria · Valutazione-soglia · MBO e svincolo · Piano operativo

Skylabs vs Venere — Le valutazioni per decidere dal 1° settembre 2026

Memo strategico riservato — Luca Martino. Basato sui deck "Skylabs AI Evolution" e "Venere", sul Company Profile 2026 e sui dati reali 2025.

Come leggere questo memo. Non è una decisione presa. In particolare **la scelta principale — mettere il focus su Skylabs o su Venere — resta aperta**: la Parte A è la sua valutazione, non il suo verdetto. Le Parti B e C sono le valutazioni che diventano rilevanti *solo se* propendi per Venere. Dove scrivo "la mia lettura" è un consiglio, non una scelta fatta al posto tuo.

PARTE A — La scelta di fondo: Skylabs AI Evolution o Venere?

A1. Le due opzioni sono la stessa mossa su settori opposti

Sono **lo stesso playbook** (buy&build ad arbitraggio di multipli: compri basso, trasformi, esci alto) applicato a **due settori opposti rispetto all'AI**. La tua bravura nel buy&build è la costante; la variabile che decide è **il settore**. Le lenti che seguono servono a valutare quale settore.

A2. Valutazione — durata dei flussi di cassa contro l'AI

- **Skylabs** consolida l'esatto business che l'AI comprime: services SF/SAP a **5,65% di EBITDA reale 2025** (12% ipotizzato nel piano), ore fatturabili deflazionate dagli agenti; CAGR 88% chiesta in un mercato in decrescita, exit 2029 (vendere l'asset disrupted *più tardi*).
- **Venere** consolida ciò che l'AI non può toccare: atto medico fisico, cash-pay, ricorrenza, vento GLP-1; l'AI è tailwind operativo, non minaccia sul ricavo; entri a inizio ciclo (0 consolidatori, 3-4x).
- *La mia lettura*: **vantaggio netto Venere** — stessa macchina, ma Skylabs controvento, Venere col vento in poppa.

A2b. Orizzonte e traiettoria del rischio: finestra corta vs runway lungo

Il vero sintetizzatore della scelta non è "quale vale di più", ma **come cambia il valore nel tempo**.

SAE — vincente, ma solo a 3-5 anni, e sempre più rischioso. - Finestra **corta e in chiusura**: il piano funziona solo se eseguito e uscito entro ~3-5 anni (2027-30). - Rischio **crescente nel tempo**: ogni anno l'AI comprime di più i ricavi services/reseller, i multipli si derano, i clienti internalizzano, i vendor disintermediano. Oltre i 5 anni SAE è verosimilmente un business in **contrazione strutturale** (a meno di diventare software-company, che non è). - → asset da **harvest ora**, non da tenere: valore massimo oggi, decrescente.

Venere — più lungo (5-10 anni), e oltre con la robotica. - Runway **lungo**: il buy-and-build compone per 5-10 anni in un settore in crescita e non-disruptabile. - Rischio **decrescente nel tempo**: più consolidi, più il multiplo si espande (4,5x → 9,5x), più sei #1 nazionale e difendibile. La curva gioca **a tuo favore**. - Il **data play** (dataset → automazione/robotica, vedi Piano) estende l'orizzonte **oltre i 10 anni**: da healthcare-services a med-tech/AI-platform, un secondo atto potenzialmente trasformatore. - **La stessa AI che uccide SAE è il motore di Venere** (moat dati + automazione futura): stesso vento, effetto opposto.

Sintesi: non è "SAE o Venere", è "**SAE adesso — finché vale — per finanziare Venere, che vale sempre di più**". Harvest la finestra corta di SAE (2027) e redeploy nel compounding lungo di Venere.

A3. Valutazione — competenza scarsa vs commodity

- In **Skylabs** la tua competenza tech è il tuo mestiere, ma **abbondante e deflazionata**.

- In **Venere** è **scarsa e difendibile**: nessuno studio ha gestionale proprietario + dataset di outcome. Il tuo DNA AI diventa il **moat**.
- *La mia lettura*: **vantaggio Venere**. Il gap che ti manca (retail/cliniche) è il più assumibile.

A4. Valutazione — dimensione × traiettoria della consulenza

La consulenza **si biforca**: perde chi vende ore, vince chi vende esiti/prodotto. **Dati reali 2025: €8,2M ricavi, €465k EBITDA (5,65%)**; target 2026 €12M di cui €3M licenze — **ma le licenze sono rivendita SF/SAP (reseller), non prodotto**: pass-through a basso valore, in disintermediazione (Agentforce, Joule). Sei **piccolo, a margine sottile, nella nicchia deflazionata**. E la scala lavora al contrario: in AI resti un pesce piccolo tra le balene; in estetica a 20-30 cliniche sei **#1 nazionale** (multiplo che si espande, 4,5x → 9,5x). - *La mia lettura*: rafforza Venere, e dice che **il valore relativo di Skylabs è massimo ora** → se scegli Venere, monetizza Skylabs presto.

A5. Valutazione — investitori e fiducia

Temi che gli investitori non si fidino su un mercato nuovo. Gestibile: ti presenti come *l'operatore che ha exitato un gruppo AI e applica la stessa disciplina + un moat tech a un mercato vergine*, con Cammalleri per la credibilità clinica e una **tranche 1 da 4-5M** che deriska prima dei 12M. Mitigante più forte: coinvolgere come **advisor i fondatori di Hippocrates Holding** (il roll-up delle farmacie "La Farmacia"), che hanno già costruito un **buy-and-build healthcare-retail regolato in Italia** — la loro presenza chiude il tuo gap di credibilità di settore agli occhi dei family office (dettaglio e cautele nel Piano). - *La mia lettura*: pari sulla facilità di raccolta, **Venere sulla solidità della tesi**.

A6. Valutazione — ritorno per te (NON è alla pari: B è superiore)

Correggo una semplificazione: confrontare i *casi di successo* (€26,5M vs €15-30M) fa sembrare i ritorni simili, ma è fuorviante per due ragioni — il successo di A è molto meno probabile, e B ha **due** fonti di valore.

A — tenere Skylabs: i €26,5M sono il successo pieno, che richiede **88% CAGR + 3 acquisizioni + 10x** in un settore disrupted e con multipli in compressione (da €465k a €10,3M di EBITDA in 4 anni): **bassa probabilità**. Risk-adjusted, la tua quota vale **~€5M (PV)**. Ed è **una sola scommessa**, senza il paracadute della vendita.

B — Venere + vendita Skylabs: due fonti diversificate: - **Vendita Skylabs**: $\sim 48\% \times €13-30M \approx €6-14M$, a breve e relativamente de-riskato (trade sale). - **Quota Venere**: $\sim 15\%$ (pre-ratchet) di un exit €90-125M $\approx €13-19M$ base, di più col **ratchet**, su 5-6 anni, in un **settore in crescita**, con **playbook provato due volte** e le protezioni strutturali (vesting, cliff, buy&build che compone). - **Totale B** $\approx €20-35M+$, su due asset con rischio/tempi diversi. Anche risk-adjusting Venere, B vale **~€15-25M** contro i $\sim €5M$ di A.

- *La mia lettura*: **hai ragione, non è alla pari**. Su base risk-adjusted B è nettamente superiore ad A (ordine di 3-4x), perché (i) il successo di A è molto meno probabile, (ii) B ha *anche* la monetizzazione di Skylabs, (iii) settore e struttura di B rendono il suo successo più raggiungibile. Il ritorno **rafforza** la propensione verso Venere.

A7. Steelman dell'opzione Skylabs (perché potresti restare)

- È un *bird-in-the-hand* (100+ persone, 60+ clienti blue-chip, ISO, cassa).
- La vision "global reference for AI" ha un **tetto teorico più alto** — **ma appartiene a una software company, non al roll-up di ore del deck** (Product $\sim 2\%$ dei ricavi; licenze reseller). Se il prodotto fosse il vero sogno, la mossa è mettere tutto su Universe, non comprare 3 consulenze.
- Cambiare settore = imparare un ambito medico regolato da zero, con rischio reputazionale a coda.

A8. Valutazione — le due decisioni sono separabili

- **Monetizzare Skylabs** (confidenza alta): regge da sola, quasi a prescindere da Venere.
- **Redeployare in Venere** (confidenza media, testabile a basso costo): la struttura a fasi (4-5M prima dei 12M) ti fa provare il potenziale con rischio limitato.
- *La mia lettura*: non "vendi perché Venere è fantastica", ma "**vendi perché è il momento giusto per Skylabs**", e usi i proventi per una scommessa a rischio limitato.

→ Raccomandazione sulla scelta di fondo

Lente	Vince
Durata cash flow vs AI · Competenza · Ciclo · Tesi per investitori	Venere
Ritorno personale risk-adjusted	Venere (nettamente: ~€15-25M vs ~€5M)
Bird-in-hand / minor rischio esecutivo	Skylabs

La mia raccomandazione (non una decisione): propendere per Venere, monetizzando Skylabs. Le parti B e C sono le valutazioni che diventano rilevanti se propendi in questa direzione.

PARTE B — Se propendi per Venere: le valutazioni su Skylabs

B1. Cosa fare di Skylabs — le quattro opzioni

Opzione	Pro	Contro	Quando ha senso
Vendita piena a strategico	Uscita netta, premio strategico, tutti i fondatori fuori	Serve svincolo; uno strategico può volerti trattenere	Vuoi uscire per Venere e i soci ti seguono
MBO (ai soci/management)	Founder-friendly, gli insider sono felici che tu esca, tieni minoranza	Servono compratori interni che <i>restino</i> + finanziamento (EBITDA sottile); prezzo più basso	Almeno un socio (Diana) vuole guidare/comprare Skylabs
Build-to-sell (Diana-led)	Exit più grande via roll-up, sfrutta la pipeline	Diana deve restare + anni + ti diluisci	Diana vuole guidarla + round SAE raccogliibili senza te
Tenere e scalare (esegui AI Evolution)	Tetto più alto se funziona	Resti al timone controvento, exit di asset disrupted, margini sottili	Credi che Skylabs diventi una software company
- <i>La mia lettura</i> : se vai su Venere e i soci ti seguono (incluso Diana), l'opzione coerente è la vendita piena a strategico ; l'MBO e il build-to-sell hanno senso solo se qualcuno resta a guidarla.			

B2. Valutazione — quando e a quanto vendere (la soglia)

Tenere fino al 2029 vale €26,5M solo nel successo pieno (CAGR EBITDA >100% da €465k). Probabilizzato e scontato, il certo-equivalente della tua quota ≈ €4,8M → **EV "indifferente" ~€10M.**

Prezzo oggi (EV)	~ multiplo	Valutazione
≥ €13-16M	~1,1-1,3x ricavi '26	Vendere batte tenere
€10-13M	~1x ricavi	Zona grigia → tendi a vendere
< €10M	<0,8x ricavi	Non svendere per i soldi (solo per focus/Venere)

Sui fondamentali un finanziario paga €5-10M; il ponte verso €13-30M lo costruiscono **logo blue-chip + storia AI + pipeline + Partner Program** (premio strategico).

B3. Valutazione — a chi vendere

Compratore	Cosa paga	Nota
Strategico ecosistema SF/SAP (es. Cegeka, Bip)	Capability AI + scala certificata + logo + pipeline → premio	Il più adatto se esci; può volerti trattenere → serve svincolo
Finanziario puro	EBITDA (basso)	Prezzo più basso; vuole management che resta
Interno (MBO)	Founder-friendly	Solo se un socio resta a guidarla
- <i>Candidati concreti: Cegeka Italia (gruppo IT belga familiare, capitale paziente, fit strategico) e Bip (PE-backed CVC, logica piattaforma/multiplo, ama una pipeline pronta). Falli competere in un processo (+ 1-2 alternativi: Reply, Lutech, Engineering, NTT Data, Accenture).</i>		

B4. Valutazione — come sfruttare pipeline e Partner Program nell'exit

- **Pipeline (Sidea ott'26, Advant mag'27, Lobra "forse" lug'27):** integrandone almeno Sidea/Advant porti sul mercato un gruppo da ~€15-20M invece di €8M, e presenti Lobra come deal che il compratore eredita → prezzo più alto.
- **Partner Program (interni entro 31/12/26 + 4 Senior Partner esterni):** de-personalizza, porta origination indipendente, blocca la retention (vesting + lock-up). Con i **leader delle acquisizioni** (CEO Lobra, commerciale Sidea, CEO Advant) forma la **panchina** che dà al compratore continuità.
- Da valutare: **selezione non nomina** (finestra di prova prima di dare ruoli chiave), e **ancorare la continuità sul deal certo (Sidea)**, non su quello incerto (Lobra).

B5. Valutazione — il vincolo key-man e come scioglierlo

Una società di servizi vale finché ci sei tu. Ma sei **quasi già svincolato**: clienti già distribuiti al business; l'unica dipendenza residua è **Diana**, risolvibile con un **GM** al suo posto. Con GM + panchina, uno strategico accetta l'uscita di tutti i fondatori (o un Chairman-light breve). "*Uscire*" = *off-operations + earn-out minimizzato + più cash upfront*.

PARTE C — Le valutazioni su Venere

C1. Valutazione — chi portare in Venere

Venere ha bisogno di **clinico (Cammalleri) + retail-ops (COO da assumere) + un owner software focalizzato** — non di un secondo team AI-consulting. Da valutare persona per persona (desiderio e fit): - **Diana (Salvo) — operatore esperto, tuo #2**

provato, e owner di uno dei due motori primari: il moat AI/dati. Poiché il dataset si instrumenta dalla clinica #1 e il decision-support entra già in Fase 2 (non è un'optionality di Fase 3), il suo ruolo è **strategico, non di supporto** → la mia lettura sale a ~22% (range 20-24%, fino a ~25% se co-leader strategico). I punti in più escono da Luca, non dagli operatori. Cautele: (a) incassa **anche** la vendita di Skylabs; (b) entra **post-closing** (~H2'27), **sincronizzato con la prima acquisizione** così struttura la clinica #1 AI-driven da subito (l'architettura dati va impostata Diana-ready fin dall'inizio; lever: accelerare Skylabs a H1'27); (c) **in Fase 1-2 è il dataset/capability a essere front-loaded, non i robot** (l'automazione fisica è lunga). Quindi **lega la parte alta della sua quota a milestone AI/dati** col reverse vesting (dataset costruito, decision-support live, POC automazione). - **Cammalleri (Marcello) — clinical partner part-time: 1 giorno/settimana sul corporate + medico del flagship del gruppo** (dove guadagna i suoi ~€240k → zero cash-burn per la società). Il suo tempo è fondamentale su 5 aree non delegabili: **origination + DD clinica dei target, protocolli/format clinico, reclutamento e retention medici, volto clinico verso investitori/venditori, qualità e reputazione clinica.** Quota ~7% (fondazione 90/10), con **impegno scritto e misurato** (deliverable trimestrali + vesting sui risultati, clausola underperformance) per evitare equity dormiente. Ottima leva: **lanciare la prima clinica brandizzata con lui** come "format lab" e showcase, poi replicare via buy-and-build. Le sue sedi, se confluiscono, valutate separatamente (related-party). *Dettaglio nel Piano.* - **Gli altri soci** — il loro ritorno è la **liquidità della vendita di Skylabs.**

⚠ Riservatezza (vincolante). I soci sono **già allineati sulla vendita insieme:** è un asset, non va rimesso in discussione. Ma l'ingresso di **Diana in Venere va tenuto riservato verso gli altri soci fino a dopo il closing** — comunicarlo prima **disgregherebbe il gruppo** e metterebbe a rischio la vendita congiunta. L'arrangement resta tra te e Diana; il suo sviluppo attivo su Venere si manifesta **post-closing** (il che è coerente anche con la pulizia IP: vedi C3).

C2. Valutazione — struttura, funding e cap table di Venere

Quando raccogliere (indipendente da Skylabs, non lo aspetta): Fase 1 **4-5M** soft-circle Set-Nov '26 → closing Q4'26/Q1'27; resto dei 12M ~2028 a metriche provate + debito. Co-invest personale da risorse personali, poi rimpolpato dalla liquidità Skylabs.

Da chi: 1 **lead family office anchor** (healthcare/consumer premium, board seat + funzione CFO) → 1-2 **angel di settore** (validazione) → 2-4 altri family office → banche in Fase 2. **Fuori** VC e PE di controllo in Fase 1.

Cap table founder — proposta (illustrativa, da negoziare):

Pre aumento di capitale (founder = 100%): | Luca | Diana (Salvo) | COO | Marcello (Cammalleri) | ---|---|---| | **59,4%** | **22%** | **12%** | **6,6%** |

Regola (nel founders' agreement): il rapporto Luca:Marcello resta 9:1 a ogni stadio — la quota di Marcello è ancorata a **1/9 di quella di Luca**, e Diana + COO + pool + investitori diluiscono i due **pro-rata**, preservando il 90:10 di fondazione. (Diana alzato da 18 a 22 perché il moat AI/dati è motore primario front-loaded in Fase 1-2; i punti extra escono da Luca, non da Marcello. Con fondazione 85/15 il rapporto ancorato diventa ~5,7:1 e Marcello ~10%.)

Post raise (€12M per il 60%, pool creato al round): investitori 60%; Luca ~16,3%, Diana ~6%, COO ~3,3%, Marcello ~1,8% (sempre 9:1 con Luca), pool ~12-13%. Leve: **ratchet** (founder verso 45-50%+ a buon exit), **cash co-invest** (aumenta la tua %), **reverse vesting** su tutti; sedi di Cammalleri valutate separatamente (related-party).

C3. Valutazione — i nodi legali da chiudere prima di muoverti

1. **Patti parasociali Skylabs** (drag/tag/prelazione/leaver): determinano se e come vendere.
2. **Non-compete** da tutti i fondatori: settore diverso aiuta, servono carve-out per Venere.
3. **Separazione IP** del gestionale: clean-room o licenza periziata, **prima** che Diana tocchi una riga.
4. **Related-party:** ogni scambio Skylabs ↔ Venere a valore di mercato, documentato.
5. **Sequenza e comunicazione ai soci:** win-win, prima del 1° settembre.

Sintesi delle raccomandazioni (tutte da validare, nessuna presa)

Valutazione	La mia raccomandazione
Scelta di fondo	Propendere per Venere , monetizzando Skylabs
Cosa fare di Skylabs	Vendita piena a strategico (se i soci ti seguono)
A chi	Cegeka / Bip in processo competitivo
Quando/prezzo	Vendere a ≥ €13-16M ; puntare €18-30M con pipeline integrata
Diana in Venere	Sì, come #2 ~22% (moat AI/dati = motore primario), vesting su milestone AI
Marcello in Venere	Clinical partner part-time ~6,6% (mantiene la pratica), rapporto 9:1 con Luca preservato a ogni round
Funding Venere	Fase 1 4-5M da family office, da Set '26; non aspetta Skylabs

Il *come* eseguire — se scegli questa direzione — è nel Piano operativo allegato.

Appendice — Quanto monetizzi davvero: SAE 2030 vs (Venere 2030 + Skylabs 2027)

Numeri illustrativi, range non forecast; lordi pre-imposta salvo dove indicato. CGT ~26% (da confermare col fiscalista) applicata a entrambi.

Scenario A — resti in SAE, exit 2030 (tua quota diluita ~26%): | Caso | EV gruppo | Tua quota lorda | ---|---|---| | Bull (piano deck: 88% CAGR, €82M ricavi, 10x) | ~€103M | **€26,5M** | | Base (grind realistico: €30-45M ricavi, 6-8x) | €25-40M | **€8-12M** | | Bear (disruption + compressione multipli) | €15-25M | **€4-6,5M** |

→ atteso ~**€8-12M**; il €26,5M è il bull a bassa probabilità.

Scenario B — vendi Skylabs 2027 + Venere:

Parte 1 — Skylabs 2027 (tua quota 48%): | Caso | EV Skylabs | Tua quota lorda | ---|---|---| | Strategico + pipeline (Sidea/Advant) | €18-30M | **€8,6-14,4M** | | Conservativo | €13M | **€6,2M** |

→ base ~**€10M**, a breve e relativamente certo.

Parte 2 — Venere (tua quota ~13-16% diluita, + ratchet): | Timing | Cliniche / EBITDA | EV | Tua quota lorda | ---|---|---| | **2030 (early, Fase 2)** | 8-12 / €4-6M | €30-48M @7-8x | **€5-8M** | | 2032-33 (maturo, Fase 3) | 20-30 / €12M+ | €90-125M | **€15-25M+** |

Totali (lordi): | Scenario | AI 2030 | Se Venere matura (2032-33) | ---|---|---| | **A — SAE 2030** | **€8-12M** (bull €26,5M) | — | | **B — Skylabs '27 + Venere** | ~**€15-18M** | ~**€25-35M** |

Netto ~26% CGT: A ~€6-9M · B@2030 ~€11-13M · B maturo ~€18-26M.

Conclusione: B batte A già a un'uscita Venere anticipata al 2030 e domina se lasci maturare Venere. A eguaglia B solo nel suo bull case (€26,5M, bassa probabilità, asset disrupted). B è anche diversificato e de-riskato (cassa Skylabs 2027 vicina e certa + upside Venere aggiuntivo). Il vero premio di Venere è ~2032-33: il 2030 ne cattura solo una parte.

Piano operativo da settembre 2026 — Da Skylabs a Venere

Piano d'azione esecutivo. Riservato. Complemento a `DECISIONE_Skylabs_vs_Venere.md`.

Cosa esegue questo piano

Questo è il *come* di **una** direzione — la raccomandazione del memo — **non una scelta già presa**: la scelta principale (mettere il focus su **Skylabs o su Venere**) la fai tu, e la valuti nella Parte A del memo. Se propendi per Venere, il piano è questo: - **Focus: Venere.** - **Skylabs: vendita piena, tutti i fondatori insieme, a uno strategico (Cegeka Italia o Bip), entro il 2027.** - **Diana in Venere** (owner del moat software/dati + tuo #2); gli altri soci incassano nella vendita. - **Pipeline (Sidea/Advant/Lobra) + Partner Program** usati per alzare il prezzo e garantire al compratore la continuità che permette a tutti di uscire.

Principio guida — cosa può correre in parallelo e cosa no

La vendita di Skylabs (2026 → closing H2'27) è retta da **advisor M&A + GM + panchina** (Partner Program e leader delle acquisizioni); non è il tuo focus operativo pieno. Quindi **sì, la porti avanti mentre avvii Venere — ma con una linea netta**:

- **In parallelo, a basso profilo, già da settembre '26**: costituzione **NewCo Venere**, conversazioni con gli **anchor family office**, e **sourcing/avvio delle prime cliniche via Cammalleri + COO**. Non coinvolge Diana e non tocca persone/IP/clienti di Skylabs → non disgrega il gruppo.
- **Solo a/dopo il closing (H2'27)**: ingresso **visibile di Diana** in Venere, **sviluppo attivo del gestionale**, e il tuo passaggio **full-time**. Perché: (a) la riservatezza sul move di Diana tiene insieme il gruppo finché tutti hanno incassato; (b) Diana serve alla **continuità per il compratore** fino al closing; (c) pulizia IP.

Le due regole invalicabili: nessuno spostamento di persone/IP/clienti da Skylabs a Venere prima della separazione formale; **Diana resta a Skylabs, visibilmente, fino al closing**. E tieni Venere **a basso profilo** durante il processo di vendita (un fondatore troppo visibilmente "altrove" può raffreddare il compratore).

FASE 1 — Settembre (Mese 1): fundamenta e allineamento

Skylabs - Con i soci (già allineati sulla vendita insieme): allinea su **tempi e processo** di vendita e sull'ingaggio degli advisor. ⚠ **Tieni riservato che Diana ti segue in Venere** — comunicarlo ora disgregherebbe il gruppo e mette a rischio la vendita-insieme: l'arrangement Diana ↔ Venere resta tra te e lui e **si manifesta dopo il closing**. - Ingaggia **avvocato M&A** (audit patti: drag/tag/prelazione/leaver) e **advisor M&A** (pre-valutazione + test d'appetito riservato su Cegeka/Bip). - Avvia lo **svincolo**: insedia/individua il **GM** (de-risk key-man, parte normale della prep di vendita); conferma la distribuzione clienti sul business layer.

Venere - Costituzione NewCo; definisci la **separazione IP** del gestionale (clean-room o licenza periziata); **lo sviluppo attivo di Diana su Venere attende il post-closing** (preserva riservatezza verso i soci e pulizia IP). - Brief soft a **2-3 family office anchor**; imposta la **cap table founder** con chi entra, incl. Diana (**riservato verso gli altri soci**). - **Advisory — avvicina i fondatori di Hippocrates Holding (il roll-up delle farmacie "La Farmacia")**: hanno costruito un **buy-and-build in un settore healthcare-retail italiano frammentato e regolato** (le farmacie) — know-how direttamente trasferibile su **consolidamento multi-sede regolato, integrazione, raccolta PE ed exit, e credibilità coi family office** (è il mitigante più forte del rischio "nuovo del settore"). Struttura: **advisory con equity/warrant** (dal pool). ⚠ **NDA e cautela**: operano in consolidamento sanitario adiacente (potenziale futuro competitor o acquirente) → allineali con equity, sii selettivo su cosa condividi del vantaggio proprietario; in positivo possono diventare **co-investitori o una via d'exit**.

🚦 **Gate 1 (fine settembre)**: processo di vendita avviato (l'allineamento dei soci sulla vendita insieme **c'è già**); advisor e legale ingaggiati; NewCo Venere costituita; arrangement Diana ↔ Venere definito **in riservatezza**.

FASE 2 — Ottobre-Novembre (Mese 2-3): lancio dei processi

Skylabs - Chiudi Sidea (ott'26) e insedia i **leader delle acquisizioni** nella panchina. - **Completa il Partner Program** (interni + 4 Senior Partner esterni) **entro il 31/12/26**, con retention lock (vesting + lock-up al change of control). - **Numeri audit-ready + info memo**; apri il **processo competitivo** (Cegeka + Bip + 1-2 alternativi) via advisor.

Venere - **Assumi il COO/AD operativo** (retail/sanità multi-sede). - **Pipeline prime cliniche**: 1 cluster (Nord-Ovest o Nord-Est), 8-12 target, **LOI su 2-4**. - **Commitment Fase 1 (4-5M)** dagli anchor; insedia comitato scientifico + advisor regolatorio/fiscale.

 **Gate 2 (fine novembre)**: Partner Program completo e panchina che regge commerciale/delivery senza i fondatori (= go per l'exit in H1'27); commitment Fase 1 Venere + COO + LOI cliniche.

FASE 3 — Dicembre 2026-H2 2027 (Mese 4-12): closing e transizione

Skylabs - **Advant (mag'27)** integrata; processo competitivo → offerte → DD → SPA → **closing entro fine 2027**. Tutti e quattro escono; **incassi**.

Venere - **Closing prime 2-4 cliniche**, avvio integrazione a 100 giorni + gestionale. - **Tu e Diana full-time su Venere** dalla chiusura della vendita.

 **Gate 3 (H2 2027)**: Skylabs venduta e incassata + prime cliniche closed + tu full-time su Venere.

FASE 4 — 2027-28 (Mese 12-24): prova del formato Venere

- KPI: **recurring 10%+**, **EBITDA/clinica +30%** in 18-24 mesi.
- Se il formato è provato → **chiami il resto dei 12M** (Fase 2 Venere) + linea di debito bancario. Se no, hai rischiato solo 4-5M.

La governance del tuo tempo (il punto che fa fallire i pivot)

Fase	Skylabs	Venere
Settembre (impostazione)	55%	45%
Ott-Nov (processi)	40%	60%
Dic-H1'27 (closing)	25% →	→ 75%
Da closing vendita	0% (uscito)	100%

Skylabs è retta da **advisor + GM + panchina**: il tuo tempo su di essa scende, non sale. Se non lo fa, non stai facendo il pivot: lo stai rimandando.

Il tempo di Diana (asimmetrico rispetto al tuo)

Tu puoi tiltare presto sulla prep di Venere (Cammalleri-led, basso profilo). **Diana no: deve restare visibilmente a Skylabs fino al closing** — per la continuità verso il compratore e per la riservatezza sul suo move.

Fase	Diana · Skylabs	Diana · Venere
Set-Dic '26	~ 90% (visibile; handover graduale al GM)	~0-10% (solo ideazione privata, no build/IP)
H1 '27 (processo vendita)	~ 85% (continuità per il compratore)	~15% (design riservato)
Closing (H2 '27)	transizione in uscita (non-compete, handover, earn-out)	ramp-up
Post-closing → 2028	0% (uscito)	100% — costruisce il gestionale/dataset (il moat)

Due attenzioni su Diana: - **Porta un segreto mentre resta a Skylabs:** deve performare il suo ruolo e **non disimpegnarsi visibilmente** fino al closing. L'handover al GM va fatto passare come normale prep di vendita, non come "Diana che se ne va". - **Il suo valore in Venere è la piattaforma, non le operations cliniche** (di cui non sa nulla): full-time dal closing a costruire il moat, mentre le prime cliniche (Fase 1) le reggono Cammalleri + COO.

Skylabs: la vendita a Cegeka Italia o Bip (il dettaglio dell'exit)

I due compratori

- **Bip** (Business Integration Partners): consulting/transformation di origine italiana, **PE-backed (CVC)**, acquisitivo, in spinta su digital/AI. Ragiona in logica piattaforma/multiplo; ama una **pipeline di roll-up già pronta**.
- **Cegeka**: gruppo IT **belga a controllo familiare** (~€1B ricavi), presente e già acquisitivo in Italia, in costruzione su AI/cloud/SAP. Capitale **paziente**, guidato dal **fit strategico**.

Entrambi vogliono ciò che hai: **capability AI + scala italiana certificata SF/SAP + logo blue-chip + persone**. La differenza di stile (Bip finanziario, Cegeka strategico) è la tua **leva competitiva**.

La pipeline come acceleratore del prezzo

Non vendere gli €8M standalone: **fai entrare Sidea (ott'26) e Advant (mag'27)**, porti sul mercato un gruppo da **~€15-20M** e presenti **Lobra come il prossimo deal** che il compratore eredita. Vendi *"una piattaforma AI certificata, con roll-up in corso"* → premio strategico.

Il Partner Program come motore di svincolo e retention

- **Completo entro 31/12/26** (interni + 4 Senior Partner esterni con client book): de-personalizza il business, porta origination indipendente, blocca la retention (equity + vesting + lock-up al change of control).
- I **leader delle acquisizioni** (CEO Lobra, direttore commerciale Sidea, CEO Advant) completano la panchina che dà al compratore la continuità.
- **5 paletti sulla panchina:** (1) selezione non nomina — finestra di prova prima di dare ruoli chiave; (2) squadra, non un uomo solo; (3) ancora la continuità sul deal **certo (Sidea)**, non su quello incerto (Lobra, "forse"); (4) valuta che i profili scalino al livello gruppo; (5) legittimità/equity/mandato chiari + tuo sponsorship.

Timeline "entro il 2027"

Periodo	Mossa
H2 '26	Svincolo (GM + panchina), numeri audit-ready, info memo, test d'appetito riservato. Chiudi Sidea (ott'26). PP completo entro 31/12
H1 '27	Processo competitivo (Cegeka + Bip + 1-2 alt.), NDA, management presentation, prime offerte. Chiudi Advant (mag'27)
H2 '27	Due diligence, SPA, closing entro fine 2027

Le 4 regole per non sbagliarlo

1. **Processo competitivo, mai monotrattativa** (Cegeka + Bip + alt.: Reply, Lutech, Engineering, NTT Data, Accenture). La tensione è il prezzo.
2. **Riservatezza a stadi**: NDA forti, dati sensibili solo a stadi avanzati (Bip è anche un concorrente).
3. **Minimizza il tuo earn-out personale, massimizza cash upfront**: la panchina resta, quindi non devi restare tu.
4. **Allinea i venditori della pipeline**: Sidea/Advant/Lobra reinvestono equity → la loro quota rolla nella struttura del compratore; mettili d'accordo prima.

Valutazione attesa

Standalone €8-14M; **con Sidea (+Advant) integrate e la panchina in piedi**, un gruppo ~€15-20M con quel profilo può puntare a **€18-30M+** in un processo competitivo Cegeka-vs-Bip. È così che pipeline + Partner Program diventano prezzo.

Venere: quando raccogliere, da chi, e le quote dei founder

Quando (la raccolta è indipendente da Skylabs e non la aspetta)

Periodo	Mossa	Importo
Set-Nov '26	Apri conversazioni anchor; soft-circle Fase 1 ; chiudi lead anchor + funzione CFO	commitment 4-5M
Dic '26 - Q1 '27	Closing Fase 1 ; firma LOI / prime 2-4 cliniche	4-5M deployati
2027 (0-18 mesi)	Deploy + prova del formato	—
~H2 2028	A metriche provate, resto dei 12M + debito bancario	fino a 12M

Il tuo **co-invest personale** lo copri con risorse personali, poi lo rimpolpi con la **liquidità di Skylabs** (fine 2027). **L'istituzionale della Fase 1 Venere non aspetta Skylabs.**

Da chi (in ordine)

1. **1 lead family office anchor** — affinità healthcare e/o consumer premium, orizzonte 5-6 anni, a suo agio col buy&build; prende board seat ed esprime la funzione CFO. Il suo "sì" trascina il club.
2. **1-2 angel di settore** (ex-operatori medspa/dentale/sanità) — validazione + deal flow; coprono il tuo gap di credibilità di settore.
3. **2-4 altri family office** per completare il club, via la rete dell'anchor.
4. **Banche** (Fase 2+) per la leva sulle acquisizioni.
5. **Small-cap PE / search fund healthcare** — non in Fase 1 (lowballano un asset pre-prova); candidati per le tranche di scala e come compratori all'exit. **Fuori**: VC (modello sbagliato) e PE di controllo in Fase 1.

Investitore strategico healthcare (es. GKSD / area Gruppo San Donato — **relazione calda di Luca**): doppio taglio. **Pro**: credibilità healthcare che de-riska il "nuovo del settore", tasche profonde (finanzia tutto il roll-up), sinergie (rete medica, governance, regolatorio), possibile via d'exit. **Rischi**: vuole più **controllo/termini**; e soprattutto **cattività strategica** — un gruppo ospedaliero è potenziale competitor e futuro acquirente: se gli dai **ROFR/esclusiva/drag sull'exit** uccidi la tensione competitiva (dove vive il multiplo) e vede il tuo playbook. **Raccomandazione**: usa la relazione (validazione + capitale + contatto d'exit), ma **in parallelo ai family office, non in esclusiva**; forma ideale = **anchor strategico bounded senza diritti che incatenano l'exit**, oppure **lead della Fase 2** (dove tasche e infrastruttura valgono di più e hai già il format provato). In Fase 1 pesa il club di family office (controllo + agilità). Proteggi il playbook in DD (disclosure a stadi, NDA).

Quanto costa ogni clinica e quanto raccogliere per le prime 2-4

Illustrativo, sulle ipotesi del deck (ricavi 0,8-2,5M, EBITDA 20%+, prezzo 3-4x).

Costo per clinica: | | EBITDA | Prezzo (3-4x) | Cash al closing (~65%) | |---|---|---|---| | Piccola (~€0,8M ricavi) | ~€160k | €0,5-0,65M | ~€0,35-0,45M | | **Tipo (~€1,2M ricavi)** | ~€240k | ~€0,84M (3,5x) | ~€0,55M | | Mid-size (~€2M ricavi) | ~€400-500k | €1,4-2M | ~€0,9-1,3M |

Il **cash al closing** è ~60-70% del prezzo: il resto è **rollover equity** (venditore reinveste, zero cassa) + **earn-out differito** (24 mesi, dai risultati). Più **capex format ~€100-200k/clinica**.

Cassa da raccogliere per le prime 2-4 (clinica-tipo ~€1M EV): | Voce | 2 cliniche | 3 cliniche | 4 cliniche | |---|---|---|---| | Cash acquisizioni (65%) | €1,3M | €1,95M | €2,6M | | Capex format (~€150k/cl) | €0,3M | €0,45M | €0,6M | | Piattaforma / team / WC / riserva | ~€0,6M | ~€0,7M | ~€0,9M | | **Cassa da raccogliere** | ~€2,2M | ~€3,1M | ~€4,1M |

→ ~€2,5-4,5M = **la Fase 1 da 4-5M del deck**. Note: (a) **paghi sull'EBITDA verificato** (dichiarato/normalizzato), spesso meno del reale gonfiato dal nero → a tuo favore; (b) per le prime 2-4 assumi **quasi tutto equity** (banche prestano poco senza track record); la **leva arriva in Fase 2** e riduce l'equity per clinica — è così che i 12M totali fanno 6-8+ cliniche.

Chi mette il capitale: founder, debito o investitori?

Le prime cliniche si comprano con il **capitale degli investitori** (raccolta Fase 1, equity), **non** con soldi dei founder e **non** con debito.

Fonte	Cosa finanzia	Quando
Bridge founder (~€100-300k, quasi tutto Luca)	Setup NewCo, advisor, pilot, runway pre-raccolta	Set-Q4'26
Raccolta investitori 4-5M (equity)	Prime 2-4 cliniche + piattaforma	Q4'26-2027
Co-invest Luca 0,5-2M (opzionale)	Skin-in-the-game + equity extra al prezzo del round	Al round
Debito bancario	Acquisizioni successive (riduce equity/clinica)	Fase 2 (2028)

Apporto founder in concreto: ≈ **zero cash necessario** per comprare le cliniche (lo fa la raccolta) — l'apporto è **equity/sweat + ruoli**. L'unico esborso *necessario* è il **bridge pre-raccolta (~100-300k, Luca)**. Il **co-invest di Luca (0,5-2M dal ricavato Skylabs)** è **opzionale ma raccomandato** (commitment + equity extra + può ancorare il round); Diana/Marcello/COO **nessun cash**. Nessuno si indebita o garantisce personalmente: compra la NewCo. Il **debito** entra solo in Fase 2 (a track record): è la leva per cui i 12M totali fanno 6-8+ cliniche.

Diritto di co-invest al prezzo del primo round entro il 31/12/27. Poiché la tua liquidità Skylabs arriva a H2'27, puoi negoziare col lead anchor il diritto di **co-investire alla valutazione del primo round fino al 31/12/27**. Preferisci la forma **impegno con funding differito** (ti impegni ora, finanzia entro la data → gli investitori lo amano, skin-in-the-game garantito) alla **opzione libera** (facoltà, non obbligo → osteggiata: eserciti solo se va bene, li diluisci a sconto). Paletti: **nel term sheet e concordato, capped** (non illimitato), e **non rompe il 9:1** (compra quote investor-side, separate dall'equity founder). Nota: a fine 2027 la società potrebbe essersi ri-valutata (format provato) → l'anchor potrebbe chiedere finestra più corta o piccolo premio oltre una certa data; un flat capped fino al 31/12/27 è difendibile come allineamento founder.

A che valutazione il primo round (4-5M)

Il deck propone la Fase 1 **alla stessa valorizzazione del round pieno** (post-money €20M → 4-5M per ~20-25%). È founder-favorable ma **una richiesta alta pre-prova** (nessuna clinica ancora, format non provato, tu nuovo del settore): è la fase più rischiosa, e di norma la fase più rischiosa prende la valutazione **più bassa**, non la stessa.

Raccomandazione — prezza la Fase 1 al suo rischio: - **Opzione A — priced round realistico: €14-18M post-money** (4-5M → ~25-33%), con lo **stack di credibilità** (tu + Cammalleri + advisor Hippocrates) e la **struttura di de-risking** (tranche a milestone, governance, format pilot). Spingi verso €18-20M **solo** con un anchor forte che valida + un primo segnale di format. - **Opzione B — stagela (preferita): primo assegno più piccolo (€2-3M a €8-12M post)** per provare format + prima clinica, poi il resto a **step-up (€20M+) sulla prova**. Match prezzo ↔ rischio, meno diluizione precoce. - **Opzione C — convertibile/SAFE con cap+sconto** (cap ~€14-18M, sconto 15-20%): **rimanda la valutazione** al round priced della Fase 2 quando avrai la prova. Veloce, niente braccio di ferro sul numero ora.

Avvertenze: il numero lo fissa il **lead anchor** (price discovery) — serve prima l'anchor, poi il prezzo; e **4-5M è tanto per un seed**: prenderlo tutto a valutazione bassa ti **sovra-diluisce al momento più rischioso** → altra ragione per B/C. Il **€20M del deck** è la **Fase 2** (post-prova), non i primi soldi.

Cap table Venere — ripartizione tra i founder

Vista 1 — Founder al 100%, PRE aumento di capitale investitori (quella che negozi ora coi co-founder):

Founder	% (pre-aucap)	Razionale
Luca — CEO, ideatore, capitale, M&A, IR + co-invest cash	59,4%	è la tua iniziativa: guidi, raccogli, co-investi
Diana (Salvo) — #2 provato, owner del moat AI/dati (motore primario), full-time	22%	il moat è front-loaded (Fase 1-2) ed è la ragione per cui il roll-up è vostro; parte alta legata a milestone AI
COO / AD operativo — full-time	12%	esecuzione format e P&L per sede
Marcello (Cammalleri) — clinical partner part-time (mantiene la pratica)	6,6%	credibilità + origination + protocolli + medici; comp dalla clinica; 1/9 di Luca
Totale founder	100%	prima di investitori e pool

Regola vincolante (founders' agreement): il rapporto Luca:Marcello resta 9:1 a ogni stadio. Marcello è ancorato a **1/9 di Luca**; Diana + COO + pool + investitori diluiscono i due **pro-rata**, preservando il 90:10 di fondazione. Diana alzato da 18 a 22 (AI/dati = motore primario già in Fase 1-2): i punti extra escono da **Luca**, non da Marcello. Lever clinico: fondando **85/15** il rapporto ancorato diventa ~5,7:1 e Marcello ~**10%**.

Vista 2 — Post aumento di capitale (raise €12M per il 60%, pool creato al round): investitori **60%**; la tua 59,4% pre si diluisce a ~**16,3%**, Diana ~**6%**, COO ~**3,3%**, Marcello ~**1,8%** (sempre 9:1 con Luca), con **option pool** ~**12-13%** per gli hire futuri.

Leve: il **ratchet** può portare i founder verso **45-50%+** a un buon exit (è lì la tua upside); il **cash co-invest** aumenta la tua % (quote investor-side comprate a €20M); **reverse vesting** su tutti; le **sedi di Cammalleri**, se confluiscono, valutate separatamente (related-party), non gonfiando la sua %; per un **COO** top usa il **pool**, non i founder.

Sequenza di ingresso dei founder (fondazione snella, ingressi successivi)

Ha senso **fondare Venere solo con te e Cammalleri** e far entrare **COO e Diana dopo**, quando l'azienda è concreta. È elegante perché allinea tre cose: **concretezza** (entrano su una società reale, non su slide), **riservatezza** (Diana non è un socio Venere visibile durante la vendita di Skylabs → nessun paper trail sul suo move) e **timing del valore** (ognuno entra quando serve).

La sequenza: 1. **Fondazione — Luca 90% / Marcello 10%**. Marcello è l'unico indispensabile all'inizio (credibilità clinica + deal flow per la prima acquisizione), come **clinical partner part-time** (vedi sotto). 2. **COO — intorno alla prima acquisizione:** serve a far girare format e P&L; probabilmente **prima** di Diana. 3. **Diana — al closing di Skylabs (≈H2'27), sincronizzato con la PRIMA acquisizione.** Diana dev'essere dentro **dalla prima clinica del gruppo** per strutturarla **AI-driven dal giorno zero** (data model, outcome capture, gestionale proprietario) — non bolted-on. Poiché è visibile solo post-closing (riservatezza), **si temporizza il closing della prima acquisizione perché coincida col suo ingresso:** pre-closing fai pilot + raccolta + pipeline (LOI/DD), ma la prima acquisizione **chiude con Diana già dentro**. Lever: accelerando la vendita Skylabs a **H1'27** anticipi entrambi. *Da subito, però, imposta l'architettura dati come principio fondativo (specifiche data model + gestionale interim Diana-ready), così lui industrializza senza retrofit.*

Perché i numeri tornano (e il rapporto si mantiene): ratio Luca:Marcello = 90:10; emettendo poi **Diana 22%** e **COO 12%** con diluizione **pro-rata**, i due scendono a **59,4% / 6,6%** (base founder) — la Vista 1 — **restando 9:1**. Il 90/10 è ancorato: Marcello = 1/9 di Luca a ogni round.

Presidio da mettere subito — founders' agreement alla fondazione: pre-definisce (a) la cap table target fully-diluted, (b) le **quote riservate e il vesting per Diana e il COO** (emesse al loro ingresso), (c) l'**option pool** (con una riserva per la futura leadership clinica), (d) **reverse vesting** su tutti, e (e) i **deliverable clinici di Marcello** cui è legato il suo vesting. Così ognuno sa la propria traiettoria e nessuno rinegozia dopo.

Il ruolo di Marcello: clinical partner part-time (mantiene la pratica)

Struttura raccomandata: **Marcello porta due cappelli** — (a) **1 giorno/settimana sulla parte societaria** (clinical partner), e (b) **medico praticante nelle cliniche del gruppo**, a partire dal **flagship** (dove guadagna i suoi ~€240k). Entra con l'**equity come unico upside** (stipendio da società minimo/nulla). Fondazione **90/10** (Luca 90 / Marcello 10). Il punto vero: **il suo impegno societario dev'essere scritto e misurato**, o un part-time con equity "non fa nulla e aspetta l'exit".

In cosa il suo tempo è fondamentale — le 5 aree non delegabili: 1. **Origination + due diligence clinica dei target.** Conosce il settore: quali studi valgono, quali medici sono credibili, i **volumi reali** di procedure (vs libri gonfiati), chi vende ed è motivato. È il "network clinico" che il deck indica come fonte n°1 di deal flow. Un finanziario non sa giudicare se i ricavi di una clinica sono clinicamente sostenibili — lui sì. 2. **Format e protocolli clinici.** Disegna i percorsi di cura, il mix clinico (iniettabili, energy-based, rigenerativa, post-GLP-1) e la meccanica del **recurring su prescrizione** — che è medica e deontologica, non commerciale. 3. **Reclutamento e retention dei medici.** Attrae e valuta i medici per il modello multi-provider, ed è il **pari** che rispettano: i medici restano per un leader clinico credibile, non per una holding. Mitiga il rischio n°1 "dipendenza dal medico". 4. **Volto clinico verso investitori e venditori.** In raccolta (family office) e in trattativa: un medico vende più volentieri a una piattaforma guidata da un collega rispettato. Chiude il tuo gap di credibilità di settore. 5. **Qualità clinica, governance e reputazione.** Sotto il comitato scientifico indipendente, è il leader clinico esecutivo responsabile di protocolli, outcome tracking e presidi reputazionali — **il rischio n°1 che distrugge brand e multiplo.**

L'impegno concreto (per evitare che non faccia nulla) — da scrivere nel founders' agreement: - **Tempo minimo (parte societaria): 1 giorno/settimana garantito** (sourcing/DD clinica, protocolli, reclutamento medici, governance) — compatibile con la pratica. - **Deliverable/KPI trimestrali:** n° di target qualificati sourced+vettati, protocolli consegnati, medici reclutati; **presenza obbligatoria** ai meeting di fundraising e alle review di qualità clinica. - **Vesting legato ai deliverable, non solo al tempo**, con **clausola di underperformance/bad-leaver**: se coasta, l'equity non maturata torna indietro. È questo che rende l'impegno reale. - **Comp:** €0-minimo dalla società per il ruolo corporate; guadagna dalla **pratica clinica nel flagship del gruppo** (comp a **valore di mercato, arm's length, related-party documentato**); l'equity è l'upside e vesta sui risultati.

La quota (90/10): a regime, dopo l'ingresso di **Diana 22%** e **COO 12%** (diluizione pro-rata), il 90/10 atterra su **Luca 59,4%** / **Marcello 6,6%** — **rapporto 9:1 preservato** (Marcello = 1/9 di Luca). Se lo vuoi più vicino a ~**10-11%**, fondi **85/15**. L'equity non assegnata a un co-founder clinico pieno resta a **Luca** e/o va **riservata nel pool** per la futura leadership clinica (un **CMO full-time** quando scali, i direttori sanitari, il KOL advisor).

Il flagship come "format lab" (con Marcello)

Idea forte: **lanciare la prima clinica brandizzata con Marcello come medico di riferimento**, per **testare e codificare il format** in un ambiente che controlli al 100%, poi replicarlo. Vantaggi: - **Prova del formato pulita:** dimostri i KPI (recurring, uplift EBITDA/clinica) in una sede tua, senza le abitudini legacy di una clinica acquisita. - **Credibilità istantanea:** Marcello come anchor doctor + **showcase** per investitori e per i medici-venditori ("guarda cosa fa il format"). - **Comp di Marcello risolta:** pratica nel flagship → guadagna lì i suoi ~€240k (market-rate, related-party), **zero cash-burn** per la società. - **Il pilota parte senza Diana** (gira su Marcello + COO + te); ma **la prima acquisizione chiude con Diana dentro** (sincronizzata col closing Skylabs) → clinica #1 AI-driven dal giorno zero. L'architettura dati va però impostata subito, Diana-ready.

Ma tienilo nel ruolo giusto: il flagship è un laboratorio, non il motore di scala. Lo **scale** resta **buy-and-build** (acquisisci cliniche profittevoli a 3-4x e le **converti** al format — è la tesi del deck, l'arbitraggio di multipli); il greenfield puro sarebbe più lento e rischioso. Quindi: **1 flagship per perfezionare e mostrare il format** → poi **acquisisci-e-converti a scala**. Usa Marcello come **template clinico e formatore** per replicare lo standard nelle sedi successive.

Come tenerlo snello — 7 regole: 1. **Affitta uno spazio + porta dentro i pazienti di Marcello (NON comprare l'immobile, NON greenfield puro).** Marcello non ha una clinica di proprietà convertibile in una città strategica (Gela è co-owned coi fratelli e fuori mercato; Milano/Verona sono studi affittati part-time). La via snella è la **terza: affitta** uno spazio dedicato a **Milano** (piccolo, espandibile), brandizzalo con fit-out leggero, e **fai confluire lì la sua pratica part-time Milano+Verona** → **location greenfield ma domanda non-greenfield** (testi il recurring su pazienti reali dal giorno 1). Marcello riceve lì e ci guadagna i suoi ~€240k (market-rate, ⚠ related-party documentato). **Non comprare l'immobile:** il capitale di Fase 1 è per format + acquisizioni, non per il mattone; semmai una **propco/sale-leaseback separata** più avanti. **Una sola sede** (Gela fuori). 2. **Capex minimo e in fasi:** affitto non acquisto; parti dagli **iniettabili** (basso capex), aggiungi i **dispositivi energy-based** (parte cara) **solo dopo** aver provato il recurring. Sede credibile, non un monumento. 3. **Time-box 6-9 mesi:** l'obiettivo non è fatturato, è

codificare il format e centrare i KPI (recurring %, uplift EBITDA/clinica, conversione, retention). Poi sposti il focus sulle acquisizioni. 4. **Strumentata, non ingioiellare**: produce **dati + playbook replicabile**, non è un profit center. **Gestionale interim off-the-shelf** (quello di Diana viene dopo), protocolli standard, fornitori esistenti. Zero bespoke pre-prova. 5. **Team leggero**: Marcello (1 g/sett + pratica) + **un site manager** + supervisione COO. Serve a *disegnare* i ruoli da replicare, non a staffare un team centrale attorno a una clinica. 6. **Una sola, non una mini-catena**. Uno basta per provare e codificare; la moltiplicazione viene dalle acquisizioni. 7. **Ring-fence capitale e attenzione**: cap esplicito e piccolo sul capitale al flagship (fetta minima dei 4-5M); **il focus tuo e del COO resta la pipeline di acquisizione**. Criterio d'uscita dal "lab": format codificato + KPI centrati + playbook + showcase pronti → da lì è la **clinica #1 della rete**, non più un progetto speciale.

Cosa c'è davvero da testare (e se serve un flagship)

Domanda chiave: cosa si testa che Marcello non fa già da solo? **Non l'atto clinico** (quello lo sa fare) — ma il **format**, il layer di piattaforma che un mono-medico non fa: - **Parte "domanda"** (recurring su prescrizione, patient journey retail con beauty advisor + recall, pagamenti rateali, cross-sell del mix, KPI): **testabile a costo quasi zero innestandolo sui pazienti che Marcello ha già**, anche negli studi attuali. **Non richiede un flagship dedicato**. - **Parte "scala"** (multi-provider / **depersonalizzazione** — paziente fedele al brand non al medico —, area management, procurement a volume): **non provabile con Marcello** (i suoi pazienti sono fedeli a lui, ed è l'unico medico) → si prova solo sulla **prima clinica acquisita e convertita**. - **La matematica della tesi** (+45% ricavi, margine 20% → 27% per clinica): la dimostri meglio su una clinica acquisita convertita che su un pilota costruito attorno a Marcello.

Quindi il flagship in affitto dedicato si giustifica SOLO se vuoi: (i) uno **showcase** brandizzato per investitori/venditori, e (ii) trialare il **multi-provider in ambiente controllato prima** di comprare. Altrimenti la via più snella è: **parte "domanda" innestata sui pazienti di Marcello nell'esistente + parte "scala" provata sulla prima acquisizione** — risparmiando capex e attenzione. Decidi il flagship in base a *queste due domande*, non per "provare il format" in generale.

Advisory board Venere — short list

Costruisci un advisory board mirato che **chiude il tuo gap di credibilità di settore** e porta know-how esecutivo. Formalizzato (lettere d'incarico + NDA), con **equity/warrant dal pool** (non dai founder) e ruoli non sovrapposti.

Advisor	Cosa porta	Aggancio
Fondatori Hippocrates Holding (La Farmacia)	Buy-and-build healthcare-retail regolato in ITA (farmacie): consolidamento multi-sede, raccolta PE, exit, credibilità coi family office	Advisory con equity/warrant ⚠️ NDA (consolidatore adiacente)
Ex-operatore catena medspa US/UK (profili tipo LaserAway, sk:n, Harley Medical)	Il format che Venere replica: recurring su prescrizione, patient journey retail, multi-provider, unit economics	Advisory internazionale
KOL clinico di medicina estetica (oltre Cammalleri)	Autorevolezza clinica, protocolli, reclutamento medici	Presiede il comitato scientifico indipendente (dal deck)
Advisor regolatorio-sanitario	Autorizzazioni regionali, pubblicità sanitaria/deontologia, struttura MSO, GDPR sanitario	Advisor dedicato dal giorno uno (dal deck)
Advisor M&A healthcare + fiscale-M&A	Origination, DD con normalizzazione ricavi, earn-out/rollover, fiscalità	Deal team (dal deck)
Consigliere indipendente in board	Contrappeso di governance	Board seat (dal deck)

Cautela trasversale: per gli advisor che operano in **consolidamento adiacente** (Hippocrates), selettività su cosa condividi del **vantaggio proprietario** (gestionale/dataset).

Partnership procurement con La Farmacia (Hippocrates tra i soci): ha senso, soprattutto perché ti dà **scala d'acquisto in prestito da subito** (in Fase 1, quando da solo non hai volume) + **logistica/supply affidabile**. Aiuta di più su **consumabili, skincare, generici**; meno sugli **iniettabili branded** (tossine/filler), dove il prezzo lo fanno i **produttori** (AbbVie/Allergan, Galderma, Merz) con deal diretti a volume — la farmacia è secondaria lì. Attenzioni: **related-party** (arm's length, a mercato,

documentato), **canale regolatorio** (tossina = farmaco su prescrizione, verifica l'approvvigionamento) e non creare **dipendenza** da un consolidatore adiacente.

Avviare Venere — i primi 6 mesi, passo per passo

Mese 1 (settembre) — Fondamenta legali e societarie 1. **Founders' agreement** Luca/Marcello (90/10, vesting, deliverable di Marcello, slot riservati Diana + COO + pool). 2. **Costituzione NewCo con architettura MSO**: una **holding di gestione** separata dalle **società mediche operative** (l'atto medico sotto direttore sanitario/struttura autorizzata). Giusta per il regolatorio e per il tema fiscale (sotto). 3. **Ingaggia gli advisor**: fiscalista/M&A, avvocato sanitario-regolatorio, notaio, commercialista. 4. **Gestionale interim** off-the-shelf + accounting + CRM. 5. **One-pager Fase 1 + data room** per la raccolta.

Mese 2-3 (ott-nov) — Clinico, capitale, pipeline (in parallelo) 6. **Marcello**: protocolli clinici + disegno dei **percorsi di cura ricorrenti**; insedia comitato scientifico e individua il direttore sanitario. 7. **Format pilot "domanda"**: innesta recurring + beauty advisor + recall + rateizzazione + KPI **sui pazienti esistenti di Marcello** e misura. 8. **Raccolta Fase 1 (4-5M)**: brief lead anchor family office + angel di settore + **advisor Hippocrates** → soft-circle. 9. **Pipeline M&A**: 1 cluster, criteri target del deck, lista 8-12, **LOI su 2-4**.

Mese 4-6 (dic-feb) — Chiudere e partire 10. **Assumi il COO**. 11. **Closing Fase 1** (4-5M). 12. **LOI + due diligence** sulle prime cliniche (con normalizzazione ricavi → nodo nero sotto). *Il closing della prima acquisizione si sincronizza con l'ingresso di Diana (~closing Skylabs, H2'27) per strutturarla AI-driven da subito; accelerando Skylabs a H1'27 lo anticipi*. 13. **Playbook integrazione a 100 giorni** pronto.

(Diana entra al closing di Skylabs, ~H2'27 — riservato fino ad allora.)

Come individuare e acquisire in fretta le prime cliniche

A. Individuarle (origination + screening)

Canali di sourcing, in ordine di potenza: 1. **Il network clinico di Marcello** — il canale n°1: sa quali studi valgono, quali medici sono credibili, chi è vicino alla pensione, i volumi reali. Congressi e associazioni (AITEB, SIME, AICPE). 2. **I fornitori di iniettabili e device** (AbbVie/Allergan, Galderma, Merz; laser/energy: Candela, Cynosure, DEKA/El.En.) — **il canale killer**: conoscono i **volumi reali** di ogni studio (vedono gli ordini) → originano deal e triangolano dichiarato vs reale (arma contro il nero). 3. **Advisor di settore (fondatori Hippocrates) + M&A/commercialisti locali** nella regione target. 4. **Outreach diretto** proprietario agli studi che rientrano nel profilo — non da broker (il miglior deal flow non passa dalle aste).

Screening — come scegliere: - **Cluster-first**: una sola regione (NO o NE), in profondità per densità (GM condiviso, procurement, marketing). Non disperdere. - **Qualità della clinica**: base pazienti reale + iniettabili ripetibili (recurring-amenable), 2+ medici o convertibile, bacino 100k+, autorizzazioni pulite. - **Qualità del venditore**: motivato (uscita generazionale), disposto a **permanenza 24-36 mesi + rollover**, allineato, zero baggage reputazionale. La disponibilità a rollare equity è il segnale più forte. - **Verificabilità dei numeri** (POS/banca/acquisti dai fornitori) e **convertibilità al format** + headroom (saturazione agende). - **La "clinica-ancora"**: la prima sia forte e credibile → hub del cluster + showcase.

B. Acquisirle in fretta

La velocità non è chiudere UN deal in fretta: è avere **2-4 deal già pronti** (sourcing + LOI + DD fatti pre-closing) da chiudere in una **finestra compressa** appena Diana entra (~H2'27). 1. **Front-load pipeline e DD (2026-H1'27)** in parallelo a pilot e raccolta → a Diana entrato **esegui, non inizi**. 2. **Deal template + playbook standard** (3-4x, 60-70% cash, earn-out, rollover, non-compete + checklist SPA/DD ripetibile): ogni deal è un "riempi il modello", non bespoke. 3. **Deal bilaterali proprietari (non aste)**: venditori motivati dal network di Marcello + intro dei fornitori → warm, veloci, economici. 4. **Prime target semplici** (proprietario singolo, autorizzazioni pulite, numeri verificabili) → chiudi in fretta e costruisci il playbook; i complessi dopo. 5. **Rollover + earn-out riducono cassa e attrito**: il venditore resta e rolla equity → allineato, colma il gap di valutazione senza braccio di ferro. 6. **Deal team + advisor dal giorno 1** (M&A, avvocato sanitario, fiscalista) + **pre-work regolatorio** (autorizzazioni/trasferimento, continuità del direttore sanitario — spesso lo step lento: scopilo presto).

Come contattarli senza spaventarli (playbook di approccio)

Con un medico **non hai una seconda prima impressione**: un contatto freddo sbagliato brucia il target. Regola: **né visita a sorpresa, né email a freddo** → **intro calda + incontro informale tra pari**.

Ordine di efficacia: (1) **intro calda** dal network di Marcello (medico-a-medico), da un **fornitore** (i rep conoscono tutti), o da un contatto comune; (2) se non c'è intro, contatto **personale e discreto** (messaggio/telefonata da te o Marcello, non email aziendale) che chiede *"uno scambio sul futuro del settore"*, zero ask di acquisto; (3) **mai** email aziendale a freddo, contatto via **reception/centralino**, broker a freddo, mass-mailing.

La sequenza: 1. **Lista + intel** (chi rientra nei criteri + segnali di apertura). 2. **Trova la via calda** per ognuno (Marcello / fornitore / contatto comune). 3. **Primo incontro informale off-site** (caffè/cena), inquadrato come **scambio tra pari, non pitch**. Apre **Marcello**, entri tu con la visione. 4. **Ascolta l'80%**: capisci la **motivazione** (pensione? admin? crescita?). Nessun numero sul tavolo. Costruisci fiducia. 5. **Se fit reciproco** → **NDA** → seller pitch → termini indicativi. 6. **Coltiva i non-pronti** (convertono in 12-24 mesi): è una pipeline da nutrire.

Riservatezza sacra: contatti il medico **personalmente e in privato**, mai tramite lo studio — la sua paura n°1 è che staff/pazienti/concorrenti scoprano che potrebbe vendere. Il rischio non è "contattare presto", è **contattare freddo e male**.

La storia da raccontare ai medici (seller pitch)

Narrazione lato venditore: **trasforma i suoi dolori in ragioni per entrare, senza toccare la sua medicina**.

Arco (una riga): *"Hai costruito uno studio che vale, ma da solo hai toccato il suo soffitto: non scala, ti tiene inchiodato (lo studio SEI tu), paghi metà in tasse o rischi col nero, e non ha vero valore di rivendita né successione. Noi togliamo il soffitto e ti de-riskiamo — senza toccare la tua medicina."*

I 5 messaggi (dolore → soluzione): 1. **Ricchezza che da solo non avrai mai**: cassa al closing + equity nella piattaforma (7-10x) = un **secondo payday più grande all'exit**. Il tuo studio da solo non ha exit. 2. **Reddito** → **capital gain**: smetti di perdere ~50% in tasse / rischiare col nero; l'equity è tassata ~26%. Legale ed efficiente. 3. **Togliamo il soffitto**: brand, marketing, recurring, rateizzazione = **più pazienti** e ticket più alti; procurement/back office/software/HR li gestiamo noi. **Più medicina, meno burocrazia** — il lordo cresce anche diventando bianco. 4. **Tieni medicina e autonomia**: la piattaforma **non interferisce sull'atto clinico**; comitato scientifico indipendente; **incentivi mai sui volumi** (nessuno ti spinge a sovra-trattare). (*Disinnesca la paura n°1: la corporatizzazione.*) 5. **De-risk e successione**: non sei più l'unico punto di rottura; multi-provider = lo studio sopravvive oltre te; uscita dignitosa **con valore**, non uno studio che muore con la pensione.

Leva del timing: i **primi** prendono le condizioni migliori e la fetta più grande — prima che la piattaforma sia costruita e de-riskata. **Meglio founder-doctor che late joiner**.

Fletti sul profilo: pensione → successione+liquidità; giovane ambizioso → crescita+equity+leadership; stressato da burocrazia/nero → togliamo l'hassle e regolarizzi conveniente.

Cosa NON dire: non promettere di preservare il nero; non aprire con "venderai più trattamenti"; non presentarti come "un fondo che ti compra" ma come "costruiamo insieme la piattaforma che il settore non ha — con medici, non burocrati". **Marcello + comitato scientifico** rendono il tutto credibile: entra in una comunità clinica guidata da pari, non vende a un fondo anonimo.

Il nodo del "nero" dei medici estetici (come affrontarlo, legalmente)

Gran parte dei medici estetici incassa in nero per non pagare ~50% di tasse. Ti crea due problemi: (a) **L'EBITDA dichiarato dei target sottostima il reale** → prezzi bassi ma venditori che pretendono credito per numeri non verificabili; (b) dentro una piattaforma fatturata il ricavo dev'essere **bianco**, e la conversione può comprimere i margini.

Regola d'oro: non paghi per il nero e non lo perpetui. Lo sostituisci con più bianco. Le 6 mosse: 1. **DD sul dichiarato/tracciabile**: normalizzi sui ricavi **fatturati/POS/banca**; **non paghi il cash non verificabile** (è frode, non bookabile). Prezzi su numeri puliti → entri basso, a tuo favore. 2. **Rischio fiscale pre-closing sul venditore**: rep & warranties + indennizzi + escrow nell'SPA. Non erediti la frode. 3. **Sostituisci il nero con più bianco via il format**: recurring a pagamento mensile +

rateizzazione + carte = pagamenti tracciabili per costruzione; il +45% del format nasce bianco. Non preservi il nero, lo rimpiazzai con un flusso bianco più grande. 4. **Rendi il bianco conveniente col rollover in EQUITY:** il medico converte reddito da lavoro (~50%) in **capital gain all'exit** (tassazione molto più bassa). È la leva legale più forte per farlo uscire dal nero: gli dai un **asset che vale a multiplo**, cosa che il nero non può dargli. 5. **Più volume dal sistema:** brand + marketing + recurring portano più pazienti → il lordo bianco su un book più grande eguaglia/supera il vecchio netto grigio. 6. **Compliance nativa = valore:** MSO, fatturazione, POS ovunque, incentivi mai sui volumi, audit (dal deck). Asset pulito e bancabile all'exit = **7-10x** vs 3-4x di studi grigi. **La regolarizzazione È l'espansione del multiplo — ed è il moat** (i grigi non possono farlo).

Due avvertenze: (a) metti in conto un **attrito di conversione** (qualche paziente cash resiste alla fattura) → modella conservativo, l'uplift deve superarlo; (b) è il **rischio d'esecuzione n°1** → serve un **fiscalista + avvocato sanitario top** (questo è framing, non parere fiscale).

Il punto strategico: il nero non è solo un ostacolo, è **la ragione per cui i medici hanno bisogno di te** — sono incastrati (non scalano, non accedono a capitale, non vendono a istituzionali). Tu offri equity capital-gain-efficient + più pazienti + un exit pulito.

Il "periodo pulito" pre-acquisizione (tecnica di DD)

Chiedere al venditore di **andare bianco 6-12 mesi prima di comprare**, osservare l'EBITDA dichiarato sotto piena fatturazione e annualizzare. Dà una **base verificabile e legale** su cui prezzare, testa direttamente il **drenaggio da sbiancamento** (quanti cash resistono alla fattura) e **filtra i venditori** (chi rifiuta è red flag: il suo "reale" è nero che evapora).

Il nodo — l'incentivo: da solo il venditore non ci sta (paga ~50% di tasse su un reddito per cui non è ancora pagato). Si risolve **firmando prima un accordo quadro vincolante col prezzo = multiplo sull'EBITDA bianco dimostrato:** *"dimostralo bianco e ti pago 3,5x su quello"* → il tempo bianco diventa ciò su cui incassa, non un costo secco.

Robustezza: 6-12 mesi (12 meglio per stagionalità); **triangola coi dati dei fornitori** (ordini iniettabili/device) anti-gaming; **introduci già gli strumenti white-friendly del format** (rateizzazione, recurring, carte) così vedi il **bianco assistito dal format**, più rappresentativo del post-acquisizione. Il periodo pulito è anche l'inizio della transizione.

Alternativa più veloce: prezzo sul **dichiarato storico + earn-out** sui risultati bianchi futuri → stesso risk-sharing senza aspettare. **Raccomandazione:** periodo pulito per le **prime cliniche** (hai tempo mentre aspetti Diana/closing Skylabs, costruisci il playbook); poi earn-out + triangolazione fornitori per la velocità.

Cosa impariamo dall'estero (e come farne un'opportunità)

I precedenti utili: roll-up di **sanità/dentale in mercati con forte informalità** (Brasile, India) + **USA** per il recurring. - **Dentale Brasile / diagnostica-dentale India** (PE-backed → spesso IPO): la tesi era **professionalizzare + formalizzare** → **EBITDA auditabile** → **multiplo premium**. La pulizia è il re-rating. - **Brasile, pagamento a rate ("carnê"):** il financing ha **reso tracciabile il ricavo e allargato il mercato** (affordability mensile). È stato lo strumento di formalizzazione — esattamente la tua rateizzazione. - **USA medspa, membership:** il ricorrente formalizza (abbonamenti fatturati) e alza l'LTV. - **Rollover in equity** (standard US/EU): il cuneo fiscale (capital gain « reddito da lavoro ») tira gli owner verso il bianco.

Le 5 lezioni: (1) **la formalizzazione È l'arbitraggio** — compri grigio a 3-4x, vendi pulito a 7-10x; l'informalità è la ragione per cui lo spread esiste; (2) **financing/recurring converte cash in bianco e allarga il mercato;** (3) **il cuneo fiscale è leva di reclutamento** (equity rollover); (4) **la compliance è brand di fiducia** verso i pazienti; (5) **cautela spagnola** (Vitaldent/Dentix, collassati): formalizza **senza iper-commercializzare** — governance clinica dominante, incentivi mai sui volumi.

I 3 ribaltamenti problema → opportunità: 1. **L'informalità = la tua opportunità di arbitraggio.** Il nero deprime i multipli d'ingresso: è ciò che ti fa comprare a poco. Senza informalità non ci sarebbe spread 3-4x → 7-10x. 2. **Il cuneo fiscale = la tua calamita per acquisire medici.** Gli offri di smettere di rischiare l'evasione e convertire il reddito in **capital gain + quota a multiplo + più pazienti**. Il problema che li opprime diventa il tuo argomento di vendita. 3. **La compliance = il tuo moat.** I grigi non scalano/non accedono a capitale/non vendono a istituzionali. Tu costruisci l'unico asset pulito, bancabile e a marchio — ciò che all'exit paga il PE.

Il "data play" di Venere: dal roll-up al dataset per l'automazione (l'upside di lungo)

La ragione per cui **questo** team (tu + Diana, DNA AI) dovrebbe fare **questo** roll-up: non solo consolidare cliniche, ma **raccogliere il dataset proprietario** che nel tempo **riduce la dipendenza dal medico** — il costo e il rischio n°1 del settore.

Il percorso, 3 livelli a orizzonti diversi: 1. **Oggi — moat di qualità (già nel deck):** outcome standardizzati (before/after controllati, aderenza protocolli, risultati per sede/medico). **Costo marginale ~zero: è un byproduct del format.** Va **strumentato bene dalla clinica #1** (imaging standard, mappe di iniezione, parametri device, outcome 30/90/180, consensi + GDPR by design). Diana costruisce il gestionale (post-closing) con questa architettura-dati in testa. 2. **Medio — AI decision-support:** l'AI **suggerisce** piano/dosaggio/protocollo sul dataset reale del gruppo; standardizza la qualità e **riduce la dipendenza dal singolo medico** (mitiga il rischio n°1). *Il medico decide* — resta fuori dal perimetro dei dispositivi medici (paletto del deck). 3. **Lungo (7-15 anni) — automazione/robotica** di procedure standardizzate e image-guided (energy-based, laser, certi iniettabili sotto guida): il dataset è il **substrato di training**. Qui sostituisci progressivamente l'**ora-medico** con la macchina → attacchi il costo e il collo di bottiglia strutturale del settore.

Perché conta anche se non arrivi ai robot: - Ri-valuta l'exit: da multiplo *healthcare-services* (7-10x EBITDA) verso multiplo *med-tech/AI-platform* — molto più alto (è il ponte tra la §Appendice-monetizzazione e un upside superiore). - **Compratore premium naturale:** un dataset proprietario di outcome + decision-support lo pagano caro un **device-maker** (Galderma, AbbVie/Allergan, produttori laser/energy) o un PE tech — anche senza automazione piena. - **È il tuo differenziatore unico:** nessun consolidatore finanziario puro può farlo. È il motivo per cui il roll-up dev'essere **tuo**, e la tua competenza AI (commodity in Skylabs) qui è **scarsa e decisiva**.

I guardrail (per non sbagliare): - Non distrarti dal core: i soldi si fanno nel roll-up (buy-and-build + formalizzazione + recurring). Il data play è **optionality**, non la base — Fase 1-3 devono inchiodare prima il roll-up "noioso". - **Regolatorio pesante** sull'automazione (MDR, responsabilità, "il medico decide"): arco lungo, non piano a breve. - **Focus oggi = basso** (strumenta solo la raccolta dati), **importanza strategica = alta** (alza l'exit e giustifica il team). Diventa un focus maggiore in **Fase 3+**, a scala di dati.

Sfruttare il modello Bending Spoons (cosa copiare, cosa NON copiare)

Venere e Bending Spoons sono **la stessa architettura di creazione di valore applicata a settori opposti** — vale la pena rubarne il metodo con gli occhi aperti. BS non inventa prodotti: **compra asset digitali maturi** (Evernote, WeTransfer, Meetup, Brightcove...), li **aggancia a un'unica piattaforma operativa centrale** (crescita, monetizzazione, dati, tecnologia, finanza), li **ottimizza** e li tiene, componendo nel tempo. È buy-and-build con una macchina centrale e una testa tech. Esattamente la tesi di Venere.

Le similitudini vere (da valorizzare): - Compri il provato, non il nuovo. BS compra prodotti con utenti e ricavi reali; noi cliniche con pazienti ed EBITDA reali. In entrambi il rischio "prodotto/mercato" è già superato: il valore si crea nell'**operare meglio**, non nell'esistere. - **Una piattaforma, molti asset.** Il vero prodotto di BS è la macchina centrale; le app sono "nodi". Per Venere la macchina è il **format playbook + procurement + brand + gestionale/data layer + GM d'area**: le cliniche sono nodi. **Corollario operativo:** investi presto e pesante sulla macchina centrale (è ciò che scala), tieni **HQ snello ed elitario** (BS gestisce decine di prodotti con un team centrale piccolo e denso). - **La monetizzazione è una scienza, non un'intuizione.** L'edge n°1 di BS è l'ingegneria della monetizzazione (abbonamenti, pricing, retention per coorte, LTV). È **identico** ai nostri leve: percorsi ricorrenti, membership, financing, upsell, saturazione agende. Trattali come BS: **misura coorti, testa prezzi, ottimizza LTV** — non "a sensazione". - **Dati + tecnologia come leva di portafoglio.** Il "platform team" di BS gira su tutti gli asset. **Questo è esattamente il ruolo di Diana:** il data play (decision-support → automazione) è la nostra piattaforma tech cross-cliniche. Da raccontargli così — è la parte che rende il progetto "suo" e non un roll-up qualsiasi. - **Ottionalità da capitale paziente.** BS non ha un exit forzato: tiene e compone. Noi manteniamo la tesi del multiple arbitrage (exit 5-10 anni), ma **costruire così che "tenere e comporre" sia attraente quanto vendere** riduce la pressione e migliora il potere negoziale con investitori e venditori. - **Struttura di capitale.** BS finanzia le acquisizioni con **debito + cassa generata**. È il nostro schema di Fase 2-3 (roll-up a leva sui flussi delle cliniche integrate): il modello è già dentro il piano.

Cosa NON copiare (il paletto che vale doppio in sanità): - BS ha una reputazione aggressiva — tagli di personale, aumenti di prezzo, funzioni amate rimosse. In un business digitale l'utente incassa e resta; in **medicina il moat È la fiducia** (paziente,

medico, deontologia). Prendiamo la **disciplina della piattaforma, non** l'etica dello spremere clienti e staff. - BS taglia costi su asset a **costo marginale ~zero**; noi abbiamo **atti medici regolati, lavoro clinico, responsabilità**: non si "licenzia il core". La depersonalizzazione è un obiettivo di sistema (multi-provider, protocolli), **non** un taglio di medici.

Come usarlo, in pratica: 1. **Framing per investitori e per Diana:** *"la Bending Spoons della medicina estetica"* — analogia italiana, riconoscibile, investibile: piattaforma centrale + dati + monetizzazione su asset provati. Usala nel pitch e nel colloquio con Salvo (senza gli aspetti reputazionali). 2. **Metti la macchina centrale al centro del budget** di Fase 1-2 (non è overhead: è il prodotto). 3. **Istituisce la "monetization science"** come funzione (coorti, pricing, LTV) fin dal format lab. 4. **Posiziona Diana come il "platform/data team"** cross-portafoglio, non come IT di supporto. 5. **Progetta l'ottimalità hold-or-sell** nella governance (patti che non ti costringano a vendere a scadenza).

Fronte finanziario e fiscale (verifica con commercialista — non è consulenza fiscale)

- **Allocazione proventi Skylabs:** (a) co-invest CEO in Venere, (b) riserva personale, (c) eventuale quota Fase 1. Definisci le tre quote prima di incassare.
- **Fiscalità della cessione:** valuta la struttura più efficiente (es. cessione via holding personale / regime PEX) **prima** del signing.
- **Non mischiare i flussi:** capitale Skylabs e Venere tracciati e separati (regola related-party).

Rischi trasversali e mitigazioni

Rischio	Mitigazione
Soci non allineati sulla vendita-insieme	Framing win-win + prezzo equo dal processo competitivo
Rivendica su IP del gestionale	Separazione IP (clean-room o licenza periziata) chiusa in Fase 1, per iscritto, prima di ogni sviluppo Venere
Skylabs si svaluta durante il processo	Muoviti nel 2026-27 (picco M&A AI); processo rapido; non far trapelare il disimpegno prima del closing
Fase 1 Venere non si finanzia	Non chiudere Skylabs finché Fase 1 non è soft-circled; gate in sequenza
Attenzione divisa	Tabella tempi vincolante; advisor + GM + panchina tengono Skylabs
Rischio reputazionale clinico (Venere)	Governance del deck (comitato scientifico, incentivi non legati ai volumi, audit, KPI reputazionali) attiva dalla prima clinica
Lobra non chiude ("forse")	Non ancorare panchina/prezzo al deal incerto: costruisci su Sidea + PP

I 3 documenti da avere pronti per settembre

1. **Deck per i soci** sulla vendita congiunta (tempi, processo, advisor) — **senza** menzionare l'arrangement Diana ↔ Venere (riservato fino al closing).
2. **Skylabs info memo** (per l'advisor M&A) — gran parte esiste nel Company Profile.
3. **Venere Fase 1 one-pager** (per gli anchor) — estratto dal deck.

KPI di successo (misura a ~settembre 2027)

- ☐ Skylabs venduta a strategico, tutti e quattro incassati, closing fatto
- ☐ Separazione IP e related-party chiuse per iscritto
- ☐ Venere: team completo (incl. Diana + COO), Fase 1 finanziata, 2-4 cliniche closed e in integrazione

- ☐ Tu: full-time su Venere, fuori da Skylabs
- ☐ Prima evidenza di uplift EBITDA/clinica sul formato